Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Judicial da Comarca de Augusto Pestana

Rua Venâncio Aires, 2470 - Bairro: Centro - CEP: 98740000 - Fone: (55) 3334-1299 - Email: fraugupestvjud@tjrs.jus.br

PETIÇÃO INFÂNCIA E JUVENTUDE CÍVEL Nº 5001047-68.2021.8.21.0149/RS

REQUERENTE: DANIELI SIQUEIRA CARDOSO
REQUERENTE: DENISE SIQUEIRA
REQUERIDO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

I - RELATÓRIO.

DANIELI SIQUEIRA CARDOSO, menor absolutamente incapaz, representada por sua genitora Denise Siqueira, ajuizou a presente ação ordinária, com pedido de tutela de urgência antecipatória, contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, todos qualificados nos autos. Aduziu, em síntese, que é portadora de Síndrone Nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares (CID 10 N04.1) e necessita do medicamento Mabthera/Rituximabe 500mg/50ml, 1 frasco ao mês, para realizar seu tratamento. Afirmou não possuir condições de suportar os valores que necessita para manter seu tratamento. Requereu tutela de urgência para o fim de determinar ao Estado do Rio Grande do Sul o fornecimento da medicação antes aludida, bem como, ao final, a procedência do pedido. Com a inicial juntou documentos.

Sobreveio nota técnica do DMJ (evento 3, NOTATEC1).

Recebida a inicial e deferida a gratuidade judiciária, mas indeferida a tutela de urgência (evento 4, DESPADEC1).

Sobreveio informação de decisão proferida em Agravo de Instrumento (Evento 23), reformando a decisão interlocutória deste Juízo e concedendo a medida liminar.

Foi deferido o pedido de bloqueio de valores requeridos pela parte autora (evento 40, DESPADEC1).

Prestadas contas no evento 68, PET1.

O demandado contestou a ação (evento 67, CONT1). Alegou, em suma, a inépcia da petição inicial por pedido genérico, remessa dos autos à Justiça Federal e falta de comprovação sobre a necessidade de uso do medicamento, postulando a improcedência da demanda.

A autora apresentou réplica (evento 79, RÉPLICA1), juntando mais documentos.

O Ministério Público, em parecer, opinou pela homologação das contas prestadas, a rejeição da preliminar aventada em contestação e a procedência da demanda (evento 82, PROMOÇÃO1).

Afastadas as preliminares e determinada a intimação das partes para produção de provas (evento 84, DESPADEC1), tendo a parte autora se manifestado pelo não interesse (evento 91, PET1).

O ente demandado, por sua vez, requereu intimação da autora para apresentação de novo laudo médico fundamentado e legível (evento 93, PET1), o que foi indeferido (evento 95, DESPADEC1).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

II - FUNDAMENTAÇÃO.

Inicialmente, homologo as contas prestadas no evento 68, PET1, tendo em vista que não foram impugnadas.

No mais, o processo teve seu trâmite regular e não há prefaciais pendentes de análise.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito da demanda, sinalo que, conforme é cediço, há alguns anos o Supremo Tribunal Federal, em sede de jurisprudência vinculante, firmou o entendimento de que a responsabilidade pela prestação do serviço público de saúde é solidária entre os entes federativos, de modo que o fornecimento de medicamentos e/ou insumos necessários à garantia da saúde do cidadão poderia ser exigido isoladamente ou em conjunto de qualquer deles, independentemente da competência administrativa para tanto (a qual serviria, a seu turno, para fins de ressarcimento do ente não competente junto ao ente competente).
Exemplos desse entendimento podem ser retirados do seguinte julgado:

> *RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA*

ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES. 2) INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 586995 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 28/06 /2011, DJe-156 DIVULG 15-08-2011 PUBLIC 16-08-2011 EMENT VOL-02566-01 PP-00073).

Ocorre que, mais recentemente, o próprio STF resolveu retomar a discussão a respeito dos contornos da responsabilidade solidária dos entes federativos, levando em conta mudanças legislativas ocorridas na Lei nº 8.080/90, bem como o crescimento vertiginoso da judicialização da saúde e os efeitos colaterais negativos que o puro e simples reconhecimento da solidariedade passiva entre os entes federativos acabou gerando (no caso, a exoneração de responsabilidade pelos entes competentes em detrimento dos demais entes que, instados judicialmente, acabavam financiando as políticas públicas de saúde daquele com seus recursos próprios, com dificuldade para seu ressarcimento).

Tal discussão, por sua vez, foi travada em sede dos ED no RE nº 855.178/SE, de relatoria para o acórdão do Min. Edson Fachin (d.j. 23.05.2019, d.p. 16.04.2020), no âmbito do qual, por maioria, a Suprema Corte brasileira resolveu, aprofundando a tese firmada em sede de repercussão geral, estabelecer termos mais claros acerca da solidariedade dos entes federativos em sede de fornecimento de medicamentos e insumos de saúde. Segue o teor da ementa:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária os entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04- 2020 PUBLIC 16-04-2020)

O dispositivo do voto condutor do acórdão, de relatoria do Min. Luiz Edson Fachin, por sua vez, deixa ainda mais clara a interpretação que, segundo o STF e em sede de entendimento vinculante (pois firmado em repercussão geral), deve ser dada à solidariedade dos entes federativos na questão da prestação da saúde, nos seguintes termos:

"3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:

i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum, prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);

ii) Afirmar que "o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente" significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas;

iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento;

v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;

vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11."

Outro trecho do voto do ministro relator para o acórdão, constante na chamada síntese do voto, também é bastante elucidativo neste sentido. Confira-se:

" Conheço dos embargos opostos pela União 1.5. Conclusão do voto: para o seguinte fim dúplice: a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; b) desprover, no mérito, o recurso examinado. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu "poder-dever" de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no

artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que "o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente" significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídicoprocessual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11."

Ou seja, segundo a hermenêutica dada pelo órgão jurisdicional de uniformização da interpretação das normas constitucionais, a solidariedade prevista nos arts. 23, II, e 196 da CF deve ser interpretada da seguinte maneira:

a) em se tratando de medicamentos/insumos integrantes da lista do SUS, o pedido de fornecimento judicial deve ser direcionado contra o ente federativo responsável por seu fornecimento, havendo a possibilidade, para fins de reforço da garantia de cumprimento, que outros entes federativos também figurem no polo passivo (desde que o primeiro, competente, lá esteja). Nessa hipótese, caso o ente legalmente competente pelo fornecimento do medicamento/insumo não figure no polo passivo (sendo a demanda movida exclusivamente contra ente(s) federativo(s) administrativamente incompetente(s) para seu fornecimento), cabe ao juiz instar a parte autora para emendar a inicial, a fim de incluir aquele no polo passivo, ainda que isso implique a alteração de competência processual, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade passiva;

b) em se tratando de medicamentos/insumos que não integrem a lista do SUS, a União Federal necessariamente deverá figurar no polo passivo, nos termos do art. 19-Q da Lei nº 8.080/90, seja exclusivamente ou em litisconsórcio passivo com Estado e/ou Município.

Ocorre que, na sessão realizada na data de 22/03/22, a 1ª Turma do STF, por maioria, REAFIRMOU o que restou decidido no Tema 793 para determinar o litisconsórcio passivo necessário da União, e, portanto, a competência da Justiça Federal, após a concessão de liminares em ações que pretendem (i) medicamentos não padronizados ou (ii) medicamentos padronizados off label, devendo ser mantida a liminar concedida pela Justiça Estadual.

Entretanto, na data de 08/06/2022 o Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetou o **Conflito de Competência nº 187.276** ao rito dos recursos repetitivos, instaurando Incidente de Assunção de Competência, determinando então, que até o julgamento definitivo do Incidente de Assunção de Competência (IAC), os Juízes Estaduais deverão se abster de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre o fornecimento de medicamentos.

Logo, considerando que ao IAC não foi atribuído efeito suspensivo, os processos abrangidos pelo conflito de competência devem ter prosseguimento regular.

Assim, passo ao julgamento do processo.

A controvérsia diz respeito ao fornecimento do medicamento solicitado pela parte autora na inicial - MABTHERA/RITUXIMABE 500mg/50ml – 1 frasco por mês.

O art. 196 da Constituição Federal de 1988 dispõe que *"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"*, considerando-se "Estado" em seu sentido amplo.

Veja-se, assim, que há solidariedade entre os entes estatais no fornecimento de medicamento para o tratamento de saúde dos cidadãos; não obstante, razoável exigir-se, para os medicamentos dispensados pelo SUS, que a parte procure, primeiro, a obtenção do seu direito administrativamente, junto ao ente com competência para tanto, segundo critérios elegidos pela Administração Pública.

Com efeito, o já referido direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal, com conteúdo de aplicabilidade imediata, **não é de direito absoluto**, podendo ser limitado conforme o caso concreto, pois a análise de pedidos de fornecimento de medicamentos exige que se observe se existe, ou não, uma política pública que abranja a prestação pleiteada, bem como a comprovação da imprescindibilidade e da urgência.

Em regra, não poderia haver interferência casuística do Poder Judiciário na distribuição de medicamentos que estejam fora da lista. Se os órgãos governamentais específicos já estabeleceram determinadas políticas públicas e delimitaram, com base em estudos técnicos, as substâncias próprias para fornecimento gratuito, não seria razoável a ingerência recorrente do Judiciário.

Não se pode olvidar que tal direito é limitado à regulamentação legal e administrativa diante da escassez de recursos, cuja alocação exige "escolhas trágicas" pela impossibilidade de atendimento integral a todos. Desse modo, a distribuição dos recursos deve primar pelo respeito ao direito à saúde de todos os que também necessitam de tratamento a ser custeado pelo Poder Público.

Somente quando o tratamento disponibilizado pelo SUS se torna ineficaz ao propósito para o qual se destina é que o Judiciário poderá deferir o fornecimento de fármaco ou a realização de procedimento não incluídos no sistema.
A princípio, não tem a pessoa direito de exigir do Poder Público medicamento que não consta do rol das listas elaboradas pelo SUS, balizadas pelas necessidades e disponibilidades orçamentárias.

Tal circunstância pode ser excepcionada caso presentes os **requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.657.156, submetido ao rito dos repetitivos, tema 106:**

> *1 – Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;*
> *2 – Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito;*
> *3 – Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).*

O primeiro e mais importante requisito estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça encarta a comprovação técnico-médica da necessidade e eficiência do medicamento pleiteado. Nada mais lógico. Trata-se de aplicação do princípio da proporcionalidade, que deve nortear todo o agir público, mormente quando em discussão intervenção judicial em políticas públicas.

Especificamente em relação ao tema, cito trabalho de Ricardo Seibel de Freitas Lima, *in* **Direito à saúde e critérios de aplicação:** SARLET, Ingo Wolfgang (org.). TIMM, Luciano Benetti (org.). Direitos fundamentais: orçamento e "reserva do possível". Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora. 2. ed. rev. e ampl. 2. Tir. 2013:

> *[...]*
>
> *Há, portanto, um meio genérico de atuação constitucionalmente definido – políticas sociais e econômicas – as quais devem atender às finalidades também explicitadas pela própria norma constitucional – ação preferencialmente preventiva e acesso universal e igualitário.*
>
> *Além disso, o art. 198, ao dispor sobre o sistema único de saúde, prevê que este deva ser organizado de forma descentralizada, com direção única em cada esfera de governo, garantido o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, e com participação da comunidade, o que reforça a necessidade de compreensão comunitária do direito à saúde.*
>
> *Por essas razões é que se defende que o modelo a ser adotado no Brasil deve contemplar critérios racionais que, entendendo o direito à saúde não como um poder do indivíduo, mas como uma relação de justiça social, permitam o acesso universal e igualitário às ações e serviços disponibilizados pelo Poder Público.*
>
> *O primeiro critério a ser observado é o respeito à separação, harmonia e independência entre Poderes, tal como preceitua o art. 2º da nossa Constituição. Com isso não se quer dizer que o Poder Judiciário não possa ser demandado e compelir qualquer ente público a determinadas prestações positivas na área da saúde. O que se quer salientar é a necessidade de que, em tais demandas, se considere, para fins de convencimento do juízo e fundamentação da decisão, a existência de legislação ou não sobre o tema, bem como o grau de desenvolvimento de políticas públicas implementadas pelo Poder Executivo.*
>
> *Essa referência é necessária, pois é altamente difundida a ideia de que o Legislativo é omisso sobre a matéria e o Executivo não fornece qualquer prestação na área da saúde, senão por interferência do Judiciário, ambas assertivas completamente dissociadas da realidade.*
>
> *Em termos legislativos, somente para citar os diplomas legais de caráter genérico e nacional, existe a Lei Federal nº 8.080, de 19 setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevendo, inclusive, em seu art. 6º, a assistência farmacêutica, e a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.*
>
> *No âmbito estadual, temos a citada Lei Estadual nº 9.908, de 16 de junho de 1993, que dispõe sobre o fornecimento gratuitamente medicamentos excepcionais a pessoas carentes, assim entendidos aqueles de uso frequente e permanente, de caráter essencial à vida de cidadãos desprovidos de recursos. Esta última muito citada como fundamento para decisões judiciais que concedem medicamentos, ainda que os critérios estabelecidos pelo legislador para este fornecimento nem sempre sejam observados.*
>
> *Além disso, existem atualmente um grande número de políticas públicas, ações econômicas e sociais desenvolvidas pelas diversas esferas de Governo, nas mais variadas áreas da saúde, objetivando a redução do risco de doenças e o acesso universal e igualitário aos serviços oferecidos.*
>
> *Especificamente na questão do fornecimento gratuito de medicamentos há vários programas, compartilhados entre as três esferas da Federação, que por convenção foram basicamente divididos em categorias de medicamentos excepcionais, medicamentos especiais e medicamentos básicos essenciais, alcançando cada qual uma diferente necessidade da população, do medicamento mais caro ao mais barato, daquele que trata as moléstias mais raras ao outro indicado para gravames comuns.*
>
> *A existência dessas políticas públicas salienta, por um lado, o comprometimento do poder Executivo, em tornar efetivo o direito à saúde, e, por outro lado, o vincula ao cumprimento das prestações a que se comprometeu, conforme decidido no primeiro precedente do Supremo Tribunal Federal citado no meu trabalho, relativo à lei de medicamentos do Estado do Rio Grande do Sul.*
>
> *O segundo critério a ser considerado são as limitações fáticas e jurídicas decorrentes da escassez de recursos públicos, o que deve conduzir a juízos que permitam que as prestações concedidas pelo Estado sejam possíveis de universalização igualitária entre potenciais beneficiários, sem que outros serviços e ações sejam prejudicados, sob pena de violação ao próprio comando do art. 196 da Constituição.*

Enfim, embora haja um dever estatal abstrato de fornecimento de medicamentos, à parte que pleiteia seu fornecimento em Juízo incumbe uma comprovação **satisfatoriamente segura** das razões de seu pedido em concreto, a fim de sustentar a condenação da Fazenda Pública, ainda mais quando o medicamento se encontra fora da lista do SUS. Dito de outro modo, este Juízo, com base inclusive no entendimento do STJ, como visto alhures, entende que o deferimento, via judicial, de medicamento fora da lista, deve ser excepcional.

No presente caso, porém, entendo que a parte logrou êxito em comprovar, de forma suficiente, a necessidade de fornecimento do medicamento pleiteado. Conforme demonstra os laudos médicos acostados no evento 1, LAUDO8 e no evento 1, LAUDO9, a demandante é portadora de Síndrone Nefrótica - lesões glomerulares focais e segmentares (CID 10 N04.1), necessitando fazer uso da medicação MABTHERA/RITUXIMABE 500mg/50ml.

Outrossim, o médico assistente da parte autora foi claro no sentido de que a ausência de fornecimento da medicação poderá acarretar na piora de seu quadro de saúde. Também esclareceu que não há medicamento similar no mercado.

Portanto, devidamente comprovada a necessidade de utilização do medicamento.

No tocante às condições financeiras, a parte autora é representada pela Defensoria Pública, cuja instituição realiza análise minuciosa dos rendimentos daqueles que pretendem ser assistidos. Além disso, o alto custo do medicamento, que chega a R$ 12.618,80 (doze mil seiscentos e dezoito reais e oitenta centavos) mensais, evidencia ser inviável a compra de tal fármaco para subsidiar o tratamento sem prejudicar a própria subsistência do núcleo familiar.

Portanto, não restam dúvidas de que a parte autora não possui condições de suportar os custos com a aquisição do medicamento.

Por fim, a autora comprovou que o medicamento possui registro na ANVISA (evento 1, OUT12).

Dessarte, tendo a parte autora comprovado todos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, a procedência do feito é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO **PROCEDENTE** o pedido deduzido na ação movida por **DANIELI SIQUEIRA CARDOSO**, menor absolutamente incapaz, representada por sua genitora, em face do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, para, confirmando a tutela provisória de urgência deferida no processo 5230099-39.2021.8.21.7000/TJRS, evento 14, DESPADEC1, condenar a parte demandada ao fornecimento do medicamento **MABTHERA/RITUXIMABE 500mg/50ml – 1 frasco por mês**, pelo tempo necessário e na quantidade indicada para o tratamento do paciente.

Condeno o réu ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em R$1.000,00 (mil reais) a serem recolhidos ao FADEP – Código 712 – Banrisul.

Interposto recurso por qualquer das partes, dê-se vista à parte contrária para contrarrazões e, em seguida, encaminhem-se os autos ao E.TJ/RS para apreciação do recurso.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496 § 3º, Inciso II do CPC), tendo em vista que o custo anual do fornecimento do medicamento fica abaixo de 500 salários mínimos.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, baixe-se.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Agendada intimação eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **TOMAS SILVEIRA MARTINS HARTMANN, Juiz de Direito**, em 7/11/2022, às 22:9:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10028195603v7** e o código CRC **110a6aab**.